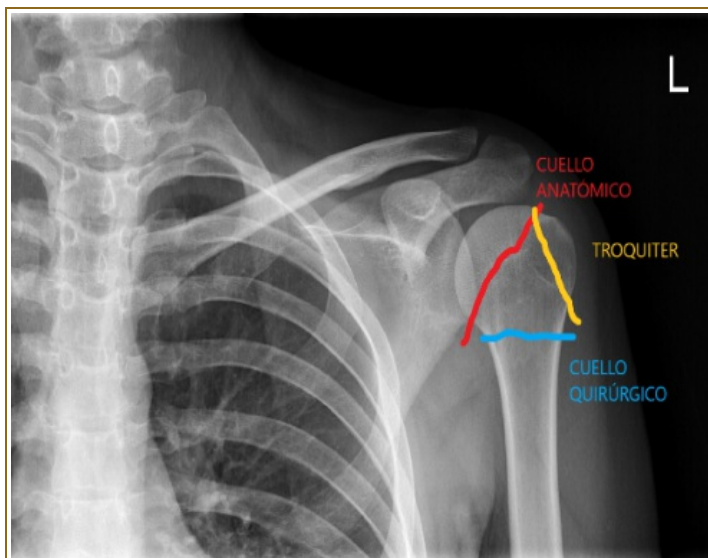


LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR

A. Roces Fernández, G. Alonso Claro, R. Marcos Mesa.

LESIONES DEL BRAZO



Radiografía normal de húmero proximal izquierdo



Calcificación manguito rotador. No patología urgente. Tto conservador

LUXACIÓN GLENO-HUMERAL

Luxación anterior

Mecanismo lesional: tras caída con el brazo en abducción, extensión y rotación externa. Sin antecedente traumático en pacientes con inestabilidad de hombro previa.

Exploración física: deformidad del hombro en charretera, se palpa la cabeza humeral anterior. Limitación funcional, sobre todo para la rotación interna y la abducción.

- Descartar afectación del nervio axilar (parestias en deltoides) y afectación del plexo braquial.
- Descartar afectación vascular.

Pruebas complementarias: Radiografía hombro anteroposterior y transtorácica.

Tratamiento: reducir lo antes posible, administrar al paciente analgesia y relajantes musculares, la clave para la reducción es que el paciente esté lo más relajado posible. Si en la radiografía se aprecian fracturas asociadas del cuello humeral no desplazadas, reducir en quirófano, bajo sedación, para evitar la “decapitación humeral”. En caso de fracturas del troquíter se puede intentar reducir en urgencias.

Maniobra de reducción: Existen varias maniobras, los autores prefieren realizar la reducción con el paciente decúbito supino, mediante tracción continua y rotación externa con el brazo en extensión, mientras se realiza una abducción progresiva. En caso de no reducir en urgencias, deberá realizarse en quirófano bajo sedación. Tras reducción inmovilizar con cabestrillo y realizar radiografía control.



Radiografía anteroposterior. Luxación gleno-humeral anterior



Radiografía transtorácica. Luxación gleno-humeral anterior



Rx. AP. Luxación gleno-humeral anterior reducida



Rx Transtorácica. Luxación gleno-humeral anterior reducida

Luxación posterior

Mecanismo lesional: por convulsiones por electrocución o ataque epiléptico, aunque también puede producirse por un traumatismo.

Exploración física: falta de deformidad llamativa, por lo que muchas pasan desapercibidas. Imposibilidad para la rotación externa (alta sospecha clínica).

Pruebas complementarias: Radiografía hombro anteroposterior (signo de la bombilla) y transtorácica.

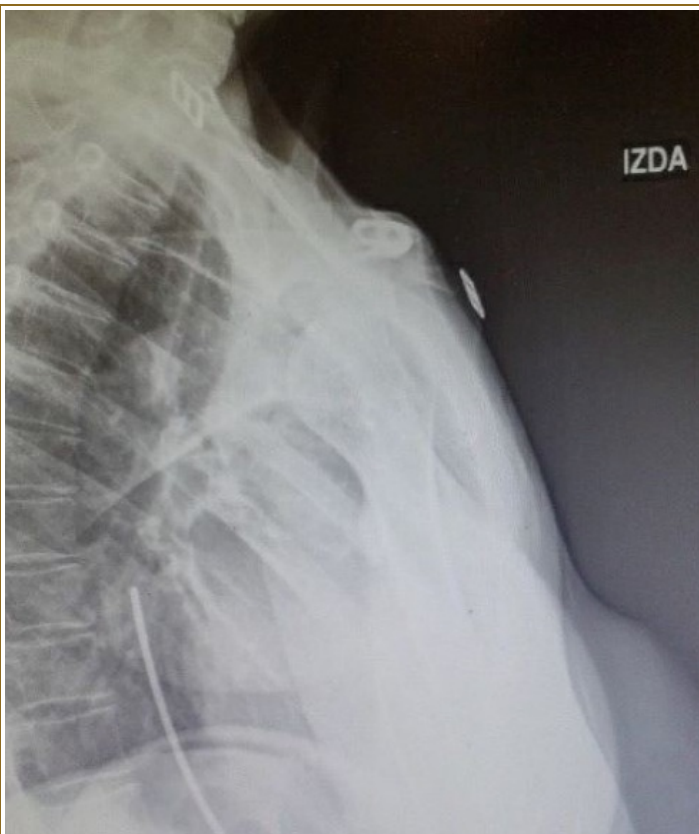
Tratamiento: reducción lo antes posible.

Maniobra de reducción: el paciente en decúbito supino, se realiza rotación interna con el brazo en adducción. En muchas ocasiones es necesario reducirlas en quirófano bajo sedación. Realizar

radiografía control tras reducción.



Rx AP. Luxación glenohumeral posterior (imagen en bombilla)



Rx transtorácica. Luxación glenohumeral posterior

FRACTURAS DE HÚMERO PROXIMAL

Muy frecuentes, relacionadas con la osteoporosis.

Mecanismo lesional: sobre todo por mecanismo indirecto, aunque también puede producirse por traumatismo directo o convulsiones.

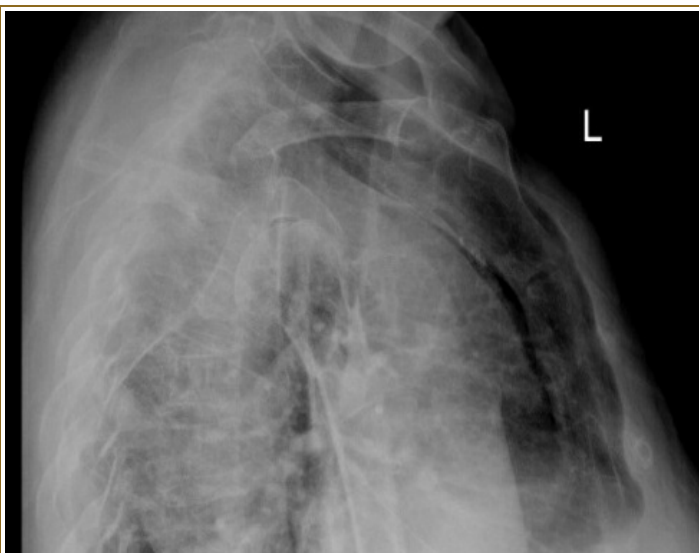
Exploración física: dolor, tumefacción y limitación funcional a nivel del hombro. A las 48 horas puede aparecer el hematoma de Hennequin en la cara interna del brazo y lateral del tórax. Descartar lesiones asociadas: nervio axilar, afectación vascular.

Pruebas complementarias: Radiografía hombro anteroposterior y transtorácica: siempre dos proyecciones, realizar en bipedestación con un cabestrillo, dejando caer el brazo. Se **clasifica** según el número de fragmentos (clasificación de Neer).

Tratamiento: debe ser individualizado según el tipo de paciente. Si fracturas no desplazadas o poco desplazadas en pacientes con baja demanda funcional o con patología asociada, sobre todo pacientes ancianos: tratamiento conservador mediante cabestrillo. Si fracturas desplazadas o pacientes jóvenes con alta demanda: avisar al traumatólogo para valorar tratamiento definitivo.



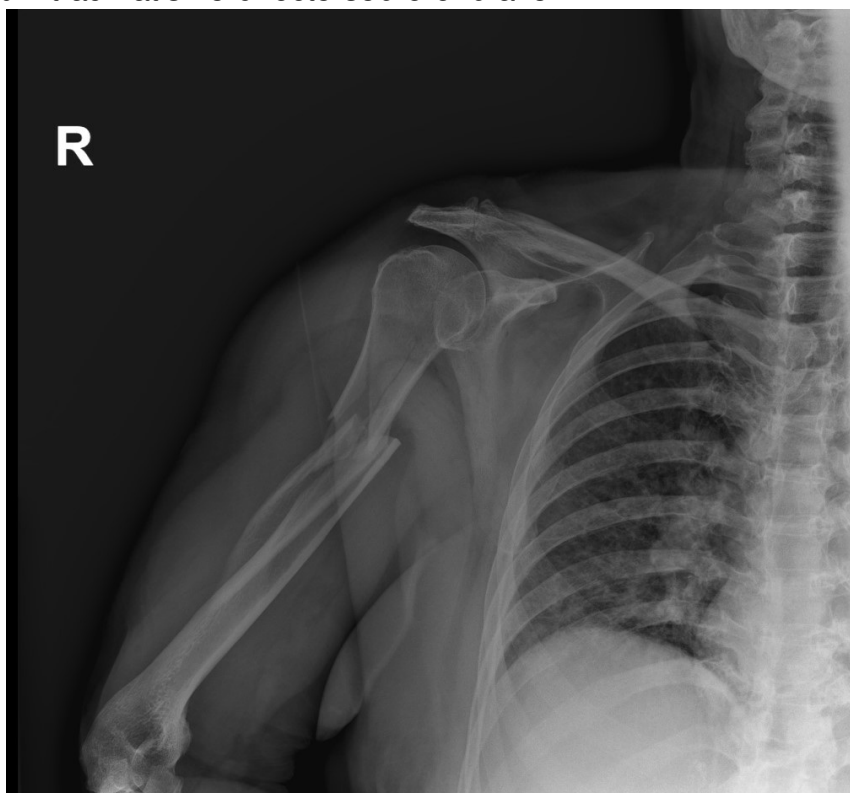
Rx. AP. Fractura proximal humero izquierdo. Cuello quirúrgico y troquíter. No desplazada. Tratamiento conservador



Rx transtorácica. Fractura humero izquierdo. Cuello quirúrgico y troquíter. No desplazada. Tratamiento conservador

FRACTURAS DIAFISARIAS DE HÚMERO

Mecanismo lesional: traumatismo directo sobre el brazo.



Fractura diafisaria del humero dere**Exploración física:** deformidad, tumefacción y limitación funcional del brazo afecto.

IMPORTANTE

- Explorar la función del nervio radial (imposibilidad para extender la muñeca).
- Comprobar que tiene buen pulso distal.

Pruebas complementarias: Radiografía humero completo (incluyendo hombro y codo) anteroposterior y transtorácica.

Clasificación: transversa, oblicua larga/corta, espiroidea, con tercer fragmento, conminuta.

Tratamiento: dependiendo del grado de desplazamiento puede ser conservador mediante la inmovilización con yeso en U o quirúrgico. Avisar al traumatólogo. Si afectación del nervio radial, dejar constancia en el informe, la mayoría de las veces son neuroapraxias, que recuperan espontáneamente. El paciente precisará una ortesis para mantener la muñeca en extensión en el periodo de recuperación.

FRACTURAS DE HÚMERO DISTAL

Mecanismo lesional: traumatismo directo, caída sobre el codo.

Exploración física: dolor, deformidad y limitación funcional del codo.

- Descartar afectación vascular.
- Descartar afectación nerviosa, sobre todo del nervio cubital y mediano.

Pruebas complementarias: Radiografía codo anteroposterior y lateral.

Clasificación: extra articulares (fractura supracondílea y dicondílea), parcialmente articulares (fracturas condilares), supraintercondíleas, fractura de capitellum y fracturas de los epicóndilos.

Tratamiento: la mayoría requieren tratamiento quirúrgico. En caso de fracturas no desplazadas o paciente con alto riesgo quirúrgico se puede optar por el tratamiento conservador mediante un yeso braquiopalmar.

ROTURA DEL BICEPS PROXIMAL

Mecanismo lesional: suele producirse en pacientes mayores de 40 años tras un sobreesfuerzo, es frecuente encontrarlo asociado a la rotura del manguito rotador.

Exploración física: dolor agudo, chasquido y equimosis en cara anterior del hombro, debajo del deltoides. Disminución de la fuerza para flexionar el codo. Signo de la bola caída o de Popeye: la masa muscular se cae hacia el codo, se nota un hachazo.



Ruptura del biceps braquial



Ruptura del biceps braquial

Pruebas complementarias: el diagnóstico es clínico, en caso de duda pedir una ecografía.

Tratamiento: conservador mediante reposo con cabestrillo 3 semanas. En caso de pacientes jóvenes y activos puede valorarse el tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Mc Rae. Ortopedia y fracturas de bolsillo. (Temas 19, 20 y 21).
- Campbell. Cirugía ortopédica. Tomo 6. Fracturas y luxaciones. (Capítulo 54).
- Rockwood & green's. Fracturas en el adulto. (Sección II, temas 21 – 30).